

I. Đúng sai

1. Bệnh vàng da xoắn khuẩn lây truyền theo đường da và niêm mạc Đ
2. Bọ chét chuột là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
3. 1 số đv hoang dã (chuột) và vật nuôi (lợn) là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
4. 1 số loài chim hoang dã là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
5. Người mang mầm bệnh thương hàn là nguồn lây truyền bệnh Đ
6. PP phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa: phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân S
7. Các biện pháp phòng chống dịch của nhóm bệnh TN đường hô hấp thì với đường truyền là rất dễ thực hiện S
8. Các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp diễn biến quanh năm và hay gặp vào những tháng lạnh, ẩm Đ
9. Vacxin sởi được chế tạo từ virus sởi sống đã làm giảm độc lực Đ
10. Vacxin cúm tạo được miễn dịch bền vững và chắc chắn S
11. Bọ chét là nguồn truyền nhiễm của bệnh dịch hạch S
12. Chim, lợn là nguồn truyền nhiễm của viêm não Nhật Bản Đ
13. Bệnh bạch hầu lây theo đường tiêu hóa S
14. Tần số (frequency) biểu thị số lần xuất hiện 1 quan sát nào đó. Ví dụ: số người có ký sinh trùng sốt rét trong máu khi kiểm tra lam máu Đ
15. Nghiên cứu bệnh chứng khó xác định mối quan hệ về mặt thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh Đ
16. Các biện pháp phòng chống dịch tổng hợp là tác động và cả 3 khâu của quá trình dịch Đ
17. Bệnh tăng HA hay tăng HA tiên phát: là tăng HA không rõ nguyên nhân, chiếm tới 90-95% các TH tăng HA Đ
18. Phụ nữ được bảo vệ và ít bị bệnh tim mạch hơn nam giới cho đến tuổi mãn kinh Đ
19. Phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn, điều trị kịp thời, làm cho tăng HA trở về bình thường là biện pháp điều trị dự phòng cấp 1 S
20. Giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành là biện pháp dự phòng cấp 2 S
21. Dự phòng cấp 2 cho bệnh tim mạch là: điều trị sớm khi mà có thể chữa khỏi được Đ
22. Điều trị ngăn không cho biến chứng xảy ra là biện pháp dự phòng cấp 3 các bệnh tim mạch Đ
23. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ sinh vật sang người S
24. Tại vùng sốt rét lưu hành có người lành mang ký sinh trùng sốt rét Đ
25. Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trùng là nguồn duy nhất Đ
26. Trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh: trẻ sinh ra từ bà và mẹ được tiêm 3 mũi vacxin uốn ván trong quá khứ và 2 mũi trong thời kỳ mang thai Đ
27. Vị trí cảm nhiễm thứ 2 quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ S
28. Côn trùng tiết túc là nguồn truyền nhiễm S
29. Tần số tuyệt đối là tần số thực của 1 ánh sáng, nó phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ S
30. Nghiên cứu biến chứng cho phép tính toán trực tiếp tỷ suất mới mắc bệnh ở cả 2 nhóm phơi nhiễm và ko phơi nhiễm hiếm S
31. Nghiên cứu biến chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm gặp S
32. Phải thông báo quá trình các bệnh: dịch tả, sốt vàng, dịch hạch Đ
33. Phụ nữ có thai mắc sốt rét về có khả năng truyền sang thai nhi Đ
34. Miễn dịch trong sốt rét là miễn dịch tự nhiên Đ
35. Pp phòng chống có hiệu quả tốt nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là cắt đường truyền nhiễm Đ
36. Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất Đ
37. Miễn dịch chủ động hình thành sau khi bị nhiễm trùng có triệu chứng hay không có triệu chứng lâm sàng Đ
38. Miễn dịch nhân tạo chủ động khi đưa các kháng nguyên vào cơ thể để tạo ra kháng thể Đ
39. Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng nhiều đến yếu tố truyền nhiễm Đ
40. Vị trí cảm nhiễm thứ 2 quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ S
41. Nghiên cứu bệnh chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm S

42. Phải thông báo quốc tế với các bệnh: dịch tả, sốt vàng, dịch hạch Đ
43. Tần số biểu thị số lần xuất hiện của 1 quan sát nào đó Đ
44. Tần số cộng dồn của 1 ô nào đó bằng tần số của chính ô đó cộng với tần số của ô trước đó Đ
45. Tần số tuyệt đối là tần số thực của 1 quan sát, nó phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ S
46. Tác nhân gây cúm là 5 loại virus sau: A, B, C, D, E S

II. Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất

1. Nhận xét nào dưới đây ko đúng với nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập:

- A. Nghiên cứu thuần tập tương lai ít nhạy cảm với các sai lệch.
- B. Nghiên cứu thuần tập tương lai cho phép tính toán trực tiếp tỷ suất mới mắc.
- C. Nghiên cứu bệnh chứng có ưu điểm là đó sẵn có số liệu cho việc phân tích nhóm.
- D. Nghiên cứu thuần tập tương lai thường được áp dụng để làm sáng tỏ các yếu tố liên quan với các bệnh hiếm gặp.@

2. Người ta tiến hành một nghiên cứu về mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá của mẹ khi mang thai và cân nặng thấp của trẻ sơ sinh. Người ta tiến hành phỏng vấn tiền sử hút thuốc lá của 340 bà mẹ để con có cân nặng thấp phát hiện ra có 40 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đồng thời người ta cũng tiến hành phỏng vấn 366 bà mẹ để con có cân nặng bình thường và phát hiện có 16 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đây là ví dụ về:

- A. Nghiên cứu ngang.
- B. Nghiên cứu thuần tập tương lai
- C. Nghiên cứu bệnh chứng@
- D. Nghiên cứu thực nghiệm.

3. Mẫu số để đo lường tỷ xuất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là:

- A. Số những trường hợp bệnh quan sát được.
- B. Số những trường hợp không có triệu chứng.
- C. Số năm người quan sát được.@
- D. Số người mất trong theo dõi

4. ở một cuộc điều tra cơ bản, 17 người trong số 1000 người đó có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc @
- B. Tỷ suất mới mắc
- C. Tỷ suất mới mắc tích lũy
- D. Tỷ suất mật độ mới mắc.

5. Một nghiên cứu thuần tập trong thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hýt thuốc lỏ đối với bệnh tim mạch người ta thấy tỉ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người nghiện thuốc lỏ cao gấp 1,6 lần so với những người không nghiện thuốc lỏ . Chỉ số dựng để đo lường tỉ lệ mắc bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc
- B. Tỷ suất mắc bệnh được chuẩn hoá
- C. Tỷ lệ chết xác định theo tuổi
- D. Tỷ suất mới mắc@

6. Trong một nghiên cứu về bệnh tăng huyết áp người ta phát hiện được 45 người mắc bệnh tăng huyết áp trong số 1000 người ở nhóm tuổi 15-49 được lấy vào nghiên cứu. Chỉ số dựng để đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc@
- B. Tỷ suất mới mắc
- C. Tỷ lệ mắc bệnh được chuẩn hoá
- D. Tỷ suất mới mắc xác định theo tuổi

7. ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60 - 64 đó mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc
- B. Tỷ suất mới mắc
- C. Tỷ lệ mắc bệnh được chuẩn hoá
- D. Tỷ suất hiện mắc xác định theo tuổi @

8. Một thay đổi trong tỉ suất hiện mắc là hậu quả thay đổi của:

- A. Tỷ suất mới mắc@
- B. Nguy cơ tương đối
- C. Nguy cơ quy thuộc
- D. Cú số người bị chết (lethality/case fatality)

9. Một nhà nghiên cứu quan tâm đến bệnh căn của vàng da sơ sinh. Để nghiên cứu vấn đề này, ụng ta đó chọn 100 trẻ em đó được chẩn đoán vàng da và 100 trẻ em sinh ra trong cùng một thời gian, ở cùng một bệnh viện mà khụng bị vàng da. Sau đó, ụng ta xem xét lại tất cả các hồ sơ sản khoa và lực để của các bà mẹ để xác định phơi nhiễm trước và trong lực để. Đây là ví dụ về:
- A. Nghiên cứu ngang. B. Nghiên cứu bệnh chứng.@
C. Nghiên cứu thuần tập tương lai. D. Thử nghiệm lờm sàng.
10. Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn đến tình huống sau:
- A. Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ giảm
B. Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng@
C. Tỷ suất mới mắc của bệnh sẽ giảm
D. Tỷ suất mới mắc của bệnh sẽ tăng
11. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết thô (crude mortality rate) ở cộng đồng A là:
- A. 300/100.000 B. 60/1.000
C. 10/1.000 @ D. 100/1.000
12. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết do lao là
- A. 20% B. 30%
C. 6% @ D. 35%
13. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết trên mắc (case fatality rate) của lao là:
- A. 6% B. 20% @
C. 2% D. Như nhau ở nam và nữ
14. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo nguyên nhân (cause specific mortality rate) đối với lao là:
- A. 60/100.000 @ B. 300/100.000
C. 200/1.000 D. 20%
15. Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo giới (sex specific mortality rate) đối với lao là:
- A. 0,5/1.000
B. Nam lớn hơn nữ
C. 50/300
D. không thể tính được từ số liệu đó cho @
16. Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi được đo bằng số trẻ chết :
- A. Từ 24 giờ đến 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống.
B. Dưới 6 tháng tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống.
C. Dưới 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống.@
D. Dưới 1 năm tuổi trên 1000 cuộc đẻ.
17. Tại một quần thể trong năm 2004 người ta đã thống kê được có 1886 trường hợp chết trong năm đó. Để tính được tỷ lệ tử vong thô, người ta cần phải thu thập thêm các thông tin.
- A. Tổng số người mắc bệnh trong quần thể đó trong năm 2004
B. Tổng dân số trong quần thể đó tại thời điểm giữa năm 2004@
C. Tổng dân số của quần thể tại thời điểm cuối năm năm 2004
D. Tổng dân số của quần thể tại thời điểm giữa năm và cuối năm đó chia đôi
18. Tỷ lệ chết/mắc của một bệnh là:

- A. Tỷ lệ chết thô/100.000 dân
 - B. Tỷ lệ chết theo nguyên nhân (case specific death rate) do bệnh đó.@
 - C. Tỷ lệ phần trăm chết ở các bệnh nhân.
 - D. Tỷ lệ chết do bệnh đó trong tất cả những người chết vì tất cả nguyên nhân
19. **Tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh bằng số chết:**
- A. Dưới 24 giờ tuổi, trên 10.000 trẻ đẻ sống
 - B. Dưới 7 ngày tuổi, trên 10.000 cuộc đẻ
 - C. Dưới 7 ngày tuổi, trên 10.000 trẻ đẻ ra sống
 - D. Dưới 28 ngày tuổi, trên 10.000 cuộc đẻ@
20. **Trong một cộng đồng gồm 1.000.000 người, có 1.000 trường hợp mắc một bệnh cấp tính, trong đó có 300 trường hợp chết vì bệnh này trong năm. Tỷ lệ chết/mắc về bệnh này trong năm là:**
- A. 3%
 - B. 1%
 - C. 10%
 - D. 30%@
21. **Trong một cộng đồng có 100.000 người, có 1.000 trường hợp bệnh và 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong năm. Tỷ lệ chết do bệnh này (tỷ lệ chết theo nguyên nhân) trong năm đó là :**
- A. 200/1.000
 - B. 200/100.000@
 - C. 800/1000
 - D. 800/100.000
22. **Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là :**
- A. Số ca hiện có của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian này
 - B. Số ca hiện có của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
 - C. Số ca mới mắc của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt đầu nghiên cứu@
 - D. Số ca mới mắc của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
23. **Trong một cộng đồng bao gồm 100.000 người, có 1000 trường hợp mắc 1 bệnh, trong đó 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong 1 năm. Tỷ lệ chết vì bệnh này là :**
- A. 0,2% @
 - B. 2%
 - C. 10%
 - D. 20%
24. **Tỷ suất hiện mắc bệnh tại một thời điểm được định nghĩa là :**
- A. Số ca hiện mắc trong một thời gian nhón với thời gian kộ dài trung bõnh của bệnh
 - B. Số ca hiện mắc trong một thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thờ gian này
 - C. Số ca hiện mắc tại một thời điểm chia cho số dân ở thời điểm đó@
 - D. Số ca hiện cú trong một thời gian chia cho số dân ở cuối thời gian này
25. **Nguy cơ mắc bệnh có thể được đo lường bằng :**
- A. Tỷ suất mới mắc.@
 - B. Tỷ suất mới mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh
 - C. Tỷ suất hiện mắc.
 - D. Tỷ suất hiện mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh
26. **Tỷ suất hiện mắc của bệnh đái đường cao hơn so với một năm trước khi bắt đầu tiến hành chương trình phát hiện và điều trị tích cực là do:**
- A. Giảm số trường hợp bệnh mà trước nghiên cứu không phát hiện được.
 - B. Giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái đường
 - C. Giảm tỷ lệ chết so với số mắc bệnh đái đường@
 - D. Tăng tỷ lệ chết theo tỷ lệ của bệnh đái đường
27. **Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là:**
- A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm@
 - B. Nguy cơ quy thuộc
 - C. Tỷ suất hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
 - D. Nguy cơ tương đối của bệnh
28. **Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm và một bệnh, những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất là :**
- A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
 - B. Nguy cơ quy thuộc
 - C. Tỷ suất hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
 - D. Nguy cơ tương đối của bệnh@

29. Ví dụ về tỷ suất hiện mắc là :

- A. Số lần bị viêm họng ở trẻ em dưới 3 tuổi hàng năm
- B. Tổng số các trường hợp mới bị ung thư tuyến tiền liệt hàng năm trên 100.000 đàn ông
- C. Số bệnh nhân đái đường ở một trường đại học
- D. Tổng số bệnh nhân bị xơ cứng lan toả trên 100.000 dân hàng năm.@

30. Có 112 người bị ốm trong đó 76 nữ và 36 nam sau một cuộc đó ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ). Tỷ lệ được tính toán đúng là :

- A. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nam $36/112 = 0,32$
- B. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nam $80/250 = 0,30$
- C. Tỷ lệ tấn công theo giới đối với nữ $76/112 = 0,70$
- D. Tỷ lệ tấn công chung @ $112/250 = 0,45$

31. Một loại vaccin phòng bệnh cúm được thử nghiệm trên một nhóm người tình nguyện là cổ nữ y tá trẻ.

Trong số 95 cá nhân được nhận tiêm vaccin, cứ 3 trường hợp bị ốm, và trong số 95 cá nhân đó nhận placebo, cứ 16 trường hợp mắc bệnh cúm trong thời gian theo dõi.

Tính toán nguy cơ tương đối (RR) Nhiễm bệnh cúm trong số những người nhận vắc xin và so với người nhận placebo :

- A. 16/3
- B. 3/16@
- C. 3/95
- D. 16/96

32. Trong một nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc Artemisinin để điều trị cho bệnh nhân sốt rét. Qua theo dõi 1892 người thấy cứ 244 trường hợp mới mắc trong thời gian theo dõi 2 năm (1999-2001). Tính tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu .

- A. 0.13 @
- B. 0.15
- C. 0.17
- D. 0.19

33. Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ. người ta đã tìm thấy có 25 người mắc bệnh ung thư vú. Năm năm sau đó, người ta đã phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh. Tỷ suất mới mắc ung thư vú sau 5 năm nghiên cứu là:

- A. $10/(5000-25)$ @
- B. $10/5000$
- C. $10/25$
- D. $10/(5000+25)$

34. NC mô tả là nghiên cứu các vấn đề sau trừ:

- A. Sự phân bố bệnh tật hay 1 vấn đề sức khỏe
- B. Các yếu tố liên quan tới quy định sự phân bố 1 vấn đề sức khỏe
- C. Mức độ, phạm vi của 1 vấn đề sức khỏe
- D. Kiểm định 1 giả thuyết nhân quả@

35. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả dùng để nhằm mục đích sau trừ:

- A. Đánh giá chiều hướng của sức khỏe cộng đồng
- B. Cơ sở cho việc lập kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế
- C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, hình thành giả thuyết
- D. Xác định yếu tố nguy cơ@

36. Nghiên cứu DTH mô tả gồm các loại dưới đây trừ:

- A. Nghiên cứu một trường hợp bệnh đơn lẻ hiếm gặp
- B. Nghiên cứu hiệu quả điều trị@
- C. Nghiên cứu một chứng bệnh
- D. Nghiên cứu tương quan

37. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm :

- A. Xác định mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh
- B. Kiểm định giả thuyết
- C. Chứng minh giả thuyết
- D. Hình thành giả thuyết@

38. Ý dưới đây không phải ưu điểm của nghiên cứu tương quan:

- A. Nhanh
- B. Dựa trên số liệu sẵn cũ
- C. Kiểm soát được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễm@
- D. Mô tả mức phơi nhiễm trung bình của quần thể

39. Mô tả một trường hợp bệnh hoặc một chứng bệnh có những ưu điểm sau trừ:

- A. Đơn giản, nhanh, dễ làm
 - B. Cơ sở ban đầu cho hình thành giả thuyết
 - C. Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn@
 - D. Cơ sở ban đầu cho việc xác định sự xuất hiện 1 vấn đề sức khỏe
- 40. Điều tra ngang khụng gắn liền với tỉ lệ nào sau đây:**
- A. Tỷ suất hiện mắc
 - B. Tỷ suất mới mắc@
 - C. Tỷ suất hiện mắc điểm
 - D. Tỷ suất hiện mắc kỳ
- 41. Điều tra ngang được tiến hành với cỡ chọn mẫu sau trừ 1 cỡ:**
- A. Mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc hệ thống
 - B. Mẫu tầng hoặc cụm
 - C. Mẫu ghép cặp@
 - D. Mẫu 30 cụm ngẫu nhiên
- 42. Điều tra ngang có những ưu điểm sau :**
- A. Nói liên được yếu tố phơi nhiễm với bệnh
 - B. Có thể làm trong thời gian ngắn, thu được kết quả nhanh chóng@
 - C. Không mắc sai số ngẫu nhiên
 - D. Loại trừ được yếu tố nhiễu
- 43. Đặc trưng không được đề cập đến trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả**
- A. Con người
 - B. Không gian
 - C. Thời gian
 - D. Căn nguyên@
- 44. Trong một nghiên cứu 500 BN và 500 người đối chứng, người ta đã tìm ra một yếu tố bệnh căn nghi ngờ ở 400 bệnh nhân và 100 người đối chứng. Nguy cơ tuyệt đối tỷ suất mới mắc ở những người cú yếu tố này là**
- A. 80% @
 - B. 40%
 - C. 20%
 - D. Không thể tính được
- 45. Nhược điểm cơ bản của cở nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố bệnh căn nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là**
- A. Tốn kém hơn và kéo dài hơn
 - B. Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ.@
 - C. Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của hậu quả bệnh
 - D. Khó chọn nhóm đối chứng
- 46. Loại nghiên cứu nào sau đây là nghiên cứu bệnh chứng:**
- A. Nghiên cứu tỷ lệ tử vong hay mắc bệnh trước đây từ đó ước lượng tỷ lệ bệnh trong tương lai.
 - B. Phân tích cở nghiên cứu trước đây ở những nơi khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau nhằm đưa ra một giả thuyết về tất cả các yếu tố nguy cơ đó biết sẽ dẫn đến bệnh mà ta nghiên cứu.
 - C. So sánh mức độ phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ ở nhóm bệnh nhân và nhóm người khỏe mạnh@
 - D. So sánh hiệu quả của phương pháp điều trị mới so với một phương pháp điều trị cũ.
- 47. Kỹ thuật ghép cặp được ỏ dụng trong nghiên cứu bệnh chứng để:**
- A. Kiểm soát cở biến số đó được biết là cú ảnh hưởng đến sự phõn bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng.@
 - B. Cú thể nghiên cứu được ảnh hưởng của cở biến số được ghép.
 - C. Kết quả được quy cho ảnh hưởng của cở biến số được ghép
 - D. Giảm cở mẫu nghiên cứu
- 48. Nhóm chứng cần thiết trong nghiên cứu bệnh chứng bởi vì:**
- A. Nhóm chứng được ghép với các nhóm bệnh về các yếu tố bệnh căn nghi ngờ.
 - B. Nhóm chứng được theo dõi để xác định liệu cú phát triển bệnh mà ta nghiên cứu hay không.
 - C. Làm tăng cỡ mẫu để có thể đạt được ý nghĩa thống kê.
 - D. Cho phép đánh giá sự khác biệt về mức độ phơi nhiễm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng@
- 49. Một nghiên cứu bệnh chứng có các đặc điểm sau, trừ:**
- A. Không quá tốn kém
 - B. Có thể ước lượng được nguy cơ tương đối
 - C. Có thể ước lượng được tỷ suất mới mắc @

- D. Có thể chọn nhóm chứng từ những bệnh khác.
50. **Nhận xét nào dưới đây là ưu điểm của một nghiên cứu bệnh chứng.**
- A. Không có hay có ít sai lệch trong việc đánh giá phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ.
 - B. Có thể nghiên cứu ảnh hưởng của một phơi nhiễm đối với nhiều bệnh
 - C. Loại trừ được sự phụ thuộc vào việc nhớ lại của đối tượng nghiên cứu.
 - D. Thường được sử dụng để nghiên cứu bệnh căn các bệnh hiếm gặp@
51. **Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm**
- A. Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu@
 - B. Nhóm bệnh nhân đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu
 - C. Nhóm người khỏe mạnh không mắc bệnh nghiên cứu
 - D. Nhóm người tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm đang nghiên cứu
52. **ở 1 cuộc điều tra cơ bản 17 người trong số 1000 người đã có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là**
- A. Tỷ suất hiện mắc @
 - B. Tỷ suất mới mắc
 - C. Tỷ suất mới mắc tích lũy
 - D. Tỷ suất mật độ mới mắc
53. **Những người mang mầm bệnh thường hàn mẫn tính phải**
- A. Cách ly
 - B. Cắt bỏ túi mật
 - C. Đăng ký và theo dõi ở trung tâm y tế dự phòng nơi họ ở @
 - D. Cách ly tại trung tâm y tế dự phòng và theo dõi 21 ngày
54. **Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là**
- A. Thể bệnh điển hình
 - B. Thể ko điển hình
 - C. Người Mang mầm bệnh
 - D. Tất cả các ý trên @
55. **Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh sởi**
- A. Pháp hiện sớm và điều trị
 - B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân
 - C. Tiêm vacxin cho trẻ từ 9-11 tháng tuổi @
 - D. Giáo dục sức khỏe và sệ sinh cá nhân
56. **Gamma globulin phòng bệnh có hiệu quả cho những người đã tiếp xúc với BN trong những bệnh sau**
- A. Sởi @
 - B. Quai bị
 - C. Thương hàn
 - D. Lỵ trực khuẩn
57. **Cơn ho điển hình của bệnh ho gà gồm**
- A. Ho 1 cơn khoảng 15-20 cái rồi chấm hết
 - B. Ho nhiều cơn, giữ các cơn ho nghe có tiếng ót @
 - C. Ho từng tiếng một có nhiều đờm trắng đục
 - D. Ho từng tiếng một, ko có đờm, thỉnh thoảng khạc ra máu
58. **Cúm là 1 trong những bệnh gây nên đại dịch lớn vì**
- A. Sự thay đổi kháng nguyên của virus @
 - B. Sự lây truyền qua nước
 - C. Thời kỳ ủ bệnh lâu dài
 - D. Không có vacxin đặc hiệu
59. **Vacxin tiêm cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ**
- A. Uốn ván @
 - B. Sởi
 - C. Sabin
 - D. BCG
60. **Vacxin tiêm 3 lần lúc trẻ 2, 3, 4, tháng tuổi là:**

- A. BH – HG – UV @
- B. Sởi
- C. Sabin
- D. BCG

61. Phương pháp có hiệu quả nhất phòng chống HIV/AIDS là

- A. Phát hiện, cách ly và điều trị sớm người nhiễm HIV
- B. Thực hiện tốt kiểm dịch biên giới
- C. Thanh toán các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm
- D. Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn @

62. Nhìn chung các biện pháp phòng chống hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm qua da và niêm mạc là

- A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân
- C. Tiêm vaccin phòng bệnh
- D. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân @

63. Mục đích điều tra dịch tễ học tại khu dịch

- A. Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp
- B. Tính tỷ suất hiện mắc @
- C. Chọn biện pháp thích hợp nhất để xử lý khu dịch
- D. Tiêm vaccin, đánh giá trình độ

64. Các vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng

- A. Dịch hạch
- B. Bại liệt @
- C. Dại
- D. Cúm

65. Cách ly có nghĩa là sự tách biệt hoạt động của

- A. Những người trong 1 hộ gia đình
- B. Các gia đình sống gần nhau
- C. Tất cả những người đã tiếp xúc @
- D. Những người nhiễm khuẩn

66. Phát hiện sớm 1 bệnh nhân trong 1 vụ dịch ko dựa vào

- A. Chẩn đoán lâm sàng
- B. Chẩn đoán xét nghiệm
- C. Điều tra dịch tễ học
- D. Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích @

67. Người Mang mầm bệnh là nguồn lây truyền bệnh

- A. Bạch hầu @
- B. Sởi
- C. Ho gà
- D. Đậu mùa

68. Nguồn lây nhiễm chính của viêm não Nhật Bản

- A. Dê, cừu
- B. Người bệnh
- C. Chim, lợn @
- D. Người khỏi mang virus

69. Nguồn truyền nhiễm chính của bệnh thương hàn

- A. Người khỏi mang vi khuẩn thương hàn @
- B. Sữa nhiễm vi khuẩn
- C. Nước nhiễm vi khuẩn
- D. Thực phẩm nhiễm vi khuẩn

70. Dịch được định nghĩa là

- A. Một bệnh có tỷ lệ mắc thấp nhưng thường xuyên xảy ra trong cộng đồng
- B. Sự xuất hiện của bệnh vượt quá số mong đợi @
- C. Bệnh có tỷ lệ tấn công vượt quá 10/1000 dân
- D. Tỷ lệ mắc hàng năm > 100.000 dân

71. Bệnh lây truyền theo phương thức trực tiếp

- A. Đại @
- B. Ly
- C. Viêm gan B
- D. Thương hàn

72. Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh

- A. Thương hàn
- B. Đại @
- C. Tả
- D. Bạch hầu

73. Ghép cặp là kỹ thuật

- A. Không được cân nhắc đến ngay cả khi thiết kế và phân tích nghiên cứu
- B. Làm tăng cỡ mẫu nghiên cứu
- C. Ghép cặp làm triệt tiêu yếu tố nhiễu @
- D. Ghép cặp làm triệt tiêu yếu tố nguy cơ

74. Ghép cặp là phép dùng để

- A. Kiểm soát các biến số đã được biết có ảnh hưởng.. @

75. Khoảng tin cậy

- A. Có thể cung cấp tất cả những thông tin về giả thiết P
- B. Phản ánh mức độ biến thiên của giả thiết ước lượng
- C. Cỡ mẫu càng lớn khoảng tin cậy càng hẹp @
- D. Cỡ mẫu càng nhỏ khoảng tin cậy càng hẹp

76. Giả thiết P trong trắc nghiệm thống kê

- A. Chỉ ra xác suất trị số quan sát được xảy ra là do các yếu tố may rủi
- B. Càng nhỏ thì giả thiết của ý nghĩa thống kê càng lớn @
- C. Ngưỡng của giả thiết trọng tâm là cố định cho mọi lĩnh vực nghiên cứu
- D. Nếu $P < 0,05$ mà bác bỏ giả thiết H_0 thì mắc sai lầm 2

77. Đánh giá vai trò của may rủi bằng

- A. Kiểm định giả thuyết @
- B. Giả thuyết P
- C. Ghép cặp
- D. Ước lượng 1 khoảng tin cậy

78. So sánh tỷ lệ tử vong do K tử cung ở những người có và không dùng nội tiết tố Oestrogen cho thấy

Tỷ lệ tử vong / 100.000 người

	Tuổi 40 – 50	Tuổi 55 - 70
Dùng oestrogen	3,0	17,0
Không dùng	1,0	6,0

Kết luận có giả thiết thu được từ số liệu trên có liên quan với tỷ lệ tử vong ở những người dùng oestrogen là

- A. Có thể có mối quan hệ giữa sử dụng oestrogen và tỷ suất mới mắc của K tử cung @
- B. Có mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng Oestrogen và tỷ suất mới mắc của K tử cung
- C. Có mối quan hệ nhân quả giữa sử dụng Oestrogen và tỷ suất mới mắc của K cổ TC tăng lên theo tuổi ko liên quan với việc sử dụng Oestrogen
- D. Tỷ lệ tử vong ở những người ko sử dụng Oestrogen thấp hơn so với người dùng Oestrogen bởi vì những triệu chứng K tử cung đã được phát hiện sớm hơn người ko dùng Oestrogen

79. Là 1 yếu tố có liên quan về nguyên nhân gây bệnh, 1 yếu tố bệnh cần phải thỏa mãn những điều kiện sau

- A. Yếu tố đó phổ biến ở những bệnh nhân hơn là những người bị bệnh
- B. Phơi nhiễm với yếu tố đó phải xảy ra trước khi phát triển bệnh @
- C. Loại trừ yếu tố đó đi sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh
- D. Yếu tố đó thấy ở tất cả các bệnh nhân

80. Chọn tình huống đúng

Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi. Những kết luận nào sau đây đúng với sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi và đưa ra bằng chứng về mối quan hệ nhân quả

- A. Nguy cơ K phổi tăng lên khi số thuốc lá hút ngày càng tăng
- B. Nguy cơ K phổi tăng lên khi khoảng thời gian hút thuốc dài hơn

- C. Những người bỏ thuốc lá có tỷ lệ K phổi ở mức trung gian so với những người ko hút thuốc lá những người hiện đang hút thuốc lá
- D. Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy tỷ lệ có vết loét tiền K tăng lên sau khi hít khói thuốc lá vào phổi @

81. Những bệnh lây truyền chủ yếu qua phân bao gồm:

- A. Sốt phát ban
- B. Sốt rét
- C. Thương hàn @
- D. Lao

82. Số trường hợp mới mắc sốt bại liệt hàng năm ở Việt Nam từ 1992 – 1996 có khuynh hướng

- A. Giảm @
- B. Tăng
- C. Không thay đổi
- D. Tùy năm

83. Tỷ lệ chết / mắc bệnh TẢ hiện nay < 1%. Yếu tố chủ yếu làm cho tỷ lệ này thấp là

- A. Điều trị bằng Tetra hoặc kháng sinh khác
- B. Gây miễn dịch cho dân trong vùng dịch
- C. Khử trùng nguồn nước bằng cloramin trong vùng dịch @
- D. Cách ly người ở bệnh viện

84. Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là

- A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm
- B. Các biện pháp đối với đường...
- C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho người dân
- D. Tất cả các ý trên @

85. Bệnh sốt xuất huyết Dengue thường gặp ở

- A. Tất cả trừ nhiệt đới
- B. Các nước khí hậu nhiệt, cận nhiệt @
- C. Ôn đới
- D. Nhiệt đới

86. Bệnh giun chỉ chủ yếu lây qua đường

- A. Da, niêm mạc
- B. Muỗi đốt
- C. Tiêu hóa
- D. Truyền máu @

87. Tác nhân gây bệnh có thể lây theo đường tình dục là

- A. Leptospira
- B. Treponema pallidum @
- C. Salmonella
- D. S. Aureus

88. Tất cả các đặc tính sau về bệnh BH – HG – HV là đúng, trừ 1 đặc trưng

- A. Tiêm chủng phòng 3 bệnh này bắt đầu lúc 2 tháng tuổi
- B. Vacxin ho gà là giải độc tố, thường gây những phản ứng phụ @
- C. Tiêm huyết thanh chống uốn ván cho những người bị vết thương bản, nếu như họ chưa được tiêm vacxin uốn ván hoặc đã quá thời gian được miễn dịch bảo vệ
- D. Gây miễn dịch chủ động phòng chống bệnh bạch hầu có hiệu quả nhất là sử dụng giải độc tố

89. Đường lây truyền chính của bệnh giang mai

- A. Máu
- B. Tiêu hóa
- C. Da
- D. Niêm mạc @

90. Các yếu tố làm tăng nguy cơ K đại tràng

- A. Thức ăn giàu mỡ và đạm động vật @
- B. Thức ăn nhiều rau
- C. Hoa quả

D. HBV

91. Các yếu tố làm tăng nguy cơ K vú

- A. Vitamin A
- B. Thức ăn giàu mỡ @
- C. Thức ăn nhiều đạm động vật
- D. Thức ăn nhiều rau

92. Biện pháp hiệu quả phòng chống K gan nguyên phát

- A. Tiêm vacxin viêm gan B cho trẻ em @
- B. Tập thể dục
- C. Thức ăn nhiều rau
- D. Chẩn đoán phát hiện sớm

93. Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

- A. Tia CIV
- B. Virus gây u nhú ở người @
- C. Hoàn cảnh kinh tế xã hội cao
- D. Điện trường và từ trường

94. Bệnh tim mạch là mô hình bệnh tật của

- A. Các nước phát triển giàu có @
- B. Các nước kém, nghèo đói
- C. Các nước đang phát triển, thu nhập tăng
- D. Các nước đang trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường

95. Các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tiên phát

- A. Ăn mặn
- B. Ít vận động
- C. Béo phì
- D. Tất cả @

96. Các biện pháp phòng chống bệnh tăng HA là

- A. Ăn nhiều rau
- B. Tăng cường vận động
- C. Phát hiện sớm và điều trị bệnh ĐTĐ
- D. Tất cả @

97. Virus gây u nhú là yếu tố nguy cơ gây K

- A. Cổ tử cung @
- B. Dạ dày
- C. Phổi
- D. Thực quản

98. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue cao nhất Việt Nam trong những năm gần đây gặp ở các khu vực

- A. Vùng núi phía Bắc
- B. Đồng bằng Bắc Bộ
- C. Miền Trung – Tây Nguyên @
- D. Miền Nam

99. Bệnh sốt xuất huyết Dengue lây qua đường

- A. Hô hấp
- B. Tiêu hóa
- C. Muối đốt
- D. Truyền máu @

100. Để đánh giá mức độ kết hợp giữa 1 phơi nhiễm và 1 bệnh những chỉ số dịch tễ học có lợi nhất là:

- A. Tỷ suất mới mắc ở những vùng có phơi nhiễm
- B. Nguy cơ quy thuộc
- C. Tần số hiện mắc phơi nhiễm
- D. Nguy cơ tương đối của bệnh @

101. Điều tra ngang được tiến hành với cách chọn mẫu sau, trừ 1 cách

- A. Mẫu ngẫu nhiên đơn hay hệ thống

- B. Mẫu tăng hoặc chùng
- C. Mẫu ghép cặp @
- D. Mẫu 30 cụm ngẫu nhiên

102. **Bệnh tai biến mạch máu não là bệnh có các biểu hiện sau**

- A. TT cơ năng thần kinh khu trú đột ngột do chấn thương, tồn tại ngắn
- B. TTCN thần kinh khu trú ko do chấn thương, tồn tại < 24h
- C. TTCN thần kinh khu trú đột ngột ko do chấn thương, kéo dài >24h, có thể để lại di chứng @
- D. TTCN thần kinh khu trú đột ngột do chấn thương, kéo dài để lại di chứng

103. **Thông tin về phơi nhiễm ít gặp sai số nhất từ nguồn**

- A. Hồ sơ có từ trước
- B. Hỏi đối tượng nghiên cứu
- C. Khám sức khỏe hay làm xét nghiệm trực tiếp
- D. Điều tra môi trường nước, không khí trực tiếp @

104. **Trong nghiên cứu can thiệp ko cần nhắc tới**

- A. Đạo đức
- B. Khả năng thực hiện
- C. Giá thành
- D. Thời gian tham gia vào nghiên cứu của nhóm đối chứng @

105. **phù hợp với bệnh cúm**

- A. Tác nhân: 5 virus Influenza A, B, C, D, E
- B. Virus B, C hay gây dịch lớn
- C. Người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất @
- D. Bệnh cúm bắt đầu lây khi BN khởi sự sốt cao

106. **Sốt bại liệt, thể lâm sàng thường gặp**

- A. Liệt mềm @
- B. Liệt không đối xứng, không đồng đều
- C. Không rõ cảm giác khách quan
- D. Teo cơ nhanh nhiều và sớm

107. **Giai đoạn 1 trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm:**

- A. Nâng cao tính an toàn
- B. Nâng cao tính hiệu quả
- C. Xác định liều thuốc sử dụng thích hợp
- D. Thử nghiệm ở những người tình nguyện khỏe mạnh @

108. **Mức độ kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh được đo lường tốt nhất bằng**

- A. Thời kỳ ủ bệnh
- B. Tỷ suất mắc của 1 bệnh trong toàn bộ dân chúng
- C. Nguy cơ quy thuộc
- D. Nguy cơ tương đối @

109. **Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh**

- A. Thương hàn
- B. Dại @
- C. Tả
- D. Bạch hầu

110. **Chim là ổ chứa thiên nhiên**

- A. Viêm gan B
- B. Sốt xuất huyết
- C. Dịch hạch
- D. Viêm não Nhật Bản @

111. **Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là:**

- A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
- B. Nguy cơ quy thuộc @
- C. Tỷ suất hiện mắc ở những người có phơi nhiễm
- D. Nguy cơ tương đối của bệnh

112. **Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm mục đích sau trừ:**

- A. Đánh giá chiều hướng của sức khỏe cộng đồng
 - B. Cơ sở cho việc lập kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế
 - C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, hình thành giả thuyết
 - D. Xác định yếu tố nguy cơ @
113. **Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm:**
- A. Xác định mối quan hệ giữa phơi nhiễm và bệnh
 - B. Kiểm định giả thuyết
 - C. Chứng minh giả thuyết
 - D. Hình thành giả thuyết @
114. **Mô tả 1 trường hợp bệnh hoặc 1 chùm bệnh có những ưu điểm sau trừ**
- A. Đơn giản, dễ làm
 - B. Cơ sở bắt đầu cho hình thành giả thuyết
 - C. Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn @
 - D. Cơ sở bắt đầu cho việc xác định sự xuất hiện 1 vấn đề sức khỏe cho người dân
115. **Đặc trưng không được đề cập đến trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả**
- A. Con người
 - B. Không gian
 - C. Thời gian
 - D. Căn nguyên @
116. **Hạn chế của kỹ thuật ghép cặp**
- A. Ghép cặp là kỹ thuật khó
 - B. Không phải kém về kinh phí và thời gian
 - C. Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiều @
 - D. Ghép cặp ko có khả năng đánh giá được hậu quả của 1 yếu tố được ghép cặp
117. **Hạn chế kết hợp giả tạo bằng**
- A. Chọn ngẫu nhiên @
 - B. Giới hạn cỡ mẫu nghiên cứu
 - C. Không chế sai số nhỏ lại
 - D. Không chế sai số bỏ cuộc
118. **Trong nghiên cứu thuần tập thường ko tính**
- A. Tỷ suất mới mắc
 - B. Tỷ suất chênh (OR) @
 - C. Nguy cơ tương đối (RR)
 - D. Nguy cơ quy thuộc
119. **Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm**
- A. Giống nhau chủ yếu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu @
 - B. Nhóm BN đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu
 - C. Nhóm người khỏe mạnh ko mắc bệnh nghiên cứu
 - D. Nhóm người tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm đang nghiên cứu
120. **Tiêm chủng ho gà chống chỉ định ở người**
- A. Trên 3 tuổi
 - B. Trên 6 tuổi
 - C. Trên 10 tuổi
 - D. Trên 13 tuổi @
121. **Bệnh có vacxin điều trị dự phòng**
- A. AIDS
 - B. Đại @
 - C. Giang mai
 - D. Lậu
122. **Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là:**
- A. Số ca hiện có của 1 bệnh trong 1 thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian này
 - B. Số ca hiện có của 1 bệnh trong thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
 - C. Số ca mới mắc của 1 bệnh trong 1 thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt đầu nghiên cứu @
 - D. Số ca mới mắc của 1 bệnh trong thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
123. **Nguy cơ mắc bệnh có thể được đo lường bằng**
- A. Tỷ suất mới mắc @

- B. Tỷ suất mới mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh
C. Tỷ suất hiện mắc
D. Tỷ suất hiện mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh
124. **Bệnh sốt xuất huyết Dengue thường gặp ở**
A. Tất cả các nước trên thế giới
B. Các nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới @
C. Các nước có khí hậu ôn đới
D. Nước có khí hậu nhiệt đới
125. **Tác nhân gây bệnh xuất huyết Dengue bởi nhóm virus sau:**
A. Dicimaviridae
B. Plaviviridae @
C. Pasmoviridae
D. Re...
126. **Các bệnh lây truyền qua đường máu không có ổ dịch...**
A. Bệnh viêm não Nhật Bản
B. Bệnh sốt rét
C. Bệnh viêm gan B, C @
D. Bệnh dịch hạch
127. **Các dịch trong cơ thể là nguyên nhân lan truyền HIV. Dịch trong cơ thể chứa virus và điều này có nghĩa là người ta sẽ phải cẩn thận. Tất nhiên, ngoài tinh dịch và máu đã được biết là có chứa virus, các dịch khác cũng có thể chứa HIV. Tránh xa nước tiểu của người khác. Đừng hôn quá sâu những người có xét nghiệm HIV dương tính. Sữa mẹ có thể chứa HIV. Thậm chí mồ hôi có thể gây nguy hiểm. Điều đó giải thích tại sao mà những vận động viên bóng rổ Mỹ từ chối chơi với những người đồng nghiệp có xét nghiệm HIV dương tính“**
A. Điều này ko đúng vì mồ hôi chỉ gây ra vấn đề nếu có tiếp xúc với vết thương hở @
B. Điều này không đúng vì chỉ những TB trong dịch tiết mới có thể chứa virus. Đờm và tinh dịch không chứa đủ những TB để có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc
C. Điều này ko đúng vì ko thể hỏi bất kỳ người nào mình muốn hôn rằng có ... hoặc anh ta đã thử nghiệm HIV hay chưa
D. Điều này hoàn toàn đúng
128. **HIV/AIDS là vấn đề của những nhóm có nguy cơ cao nhất định. Nếu chúng ta có thể tác động tới những nhóm này để thay đổi hành vi của họ, chúng ta sẽ có thể giải quyết tư vấn HIV/AIDS cho những nhóm quần thể khác**
A. Điều này đúng nhưng chúng ta phải nêu được tên những nhóm đó ra như nhóm đồng tính luyến ái, nhóm gái mại dâm, nhóm người tình dục bừa bãi
B. Điều này đúng nhưng chúng ta còn phải nêu tên những nhóm nguy cơ cao như nhóm người mắc bệnh ưa chảy máu, nhóm trẻ em
C. Điều này ko đúng vì rất khó thay đổi hành vi
D. Điều này ko đúng vì thuật ngữ “nhóm có nguy cơ cao” không còn được dùng trong HIV/AIDS. Nó làm những người không thuộc nhóm này hiểu nhầm về sự an toàn của mình và làm tăng sự e dè ko cần thiết đối với những nhóm nhất định của xã hội @
1. **“bất kể tiếp xúc với máu của người khác đều có thể là nguy hiểm. Quá nhiều người hiện đang nhiễm HIV. Những người bị HIV không nên dùng bàn chải đánh răng chung với những người khác. Lý do nhiều người ở Châu Phi nhiễm HIV là do muỗi sốt rét, muỗi này đốt người nhiễm virus sau đó một thời gian lại đốt người khác và bên cạnh việc truyền sốt rét nó còn truyền HIV “**
A. Điều này không đúng vì người ta chưa biết đến một trường hợp truyền HIV nào thông qua việc dùng chung bàn chải đánh răng hoặc do muỗi đốt @
B. Điều này không đúng vì sự lan truyền HIV ở châu Phi là do có quá nhiều trường hợp đồng tính luyến ái
C. Điều này không đúng vì nhiễm HIV do dùng chung bàn chải đánh răng là không thể được
D. Điều này hoàn toàn đúng
2. **Có ý kiến cho rằng “ Chính phue phải hành động khẩn cấp. Cho đến nay chưa có nhiều người bị nhiễm HIV, chính phủ nên cách ly những người bị HIV để bảo vệ cho những người khác “**

- A. Điều này đúng nhưng nhìn bề ngoài chúng ta không thể biết được ai là người nhiễm HIV. Có thể phát hiện người nhiễm HIV bằng xét nghiệm và người đó phải được cách ly. Tuy nhiên có 10 người khác vẫn tiếp tục lây truyền HIV
- B. Điều này không đúng vì Cách tốt nhất để bảo vệ mọi người là giáo dục họ đường lây truyền để họ có thể bảo vệ cho bản thân họ @
- C. Điều này không đúng vì nếu cách ly những người nhiễm HIV ra một nơi sẽ dẫn đến tập trung và tăng virus dẫn đến bùng nổ dịch nhiễm HIV
- D. Điều này hoàn toàn không đúng
3. **Cách phòng lây truyền HIV hiệu quả nhất là sử dụng bao cao su. Nếu tất cả mọi người đều sử dụng bao cao su thì chỉ có một số ít người không sử dụng bao cao su là bị nhiễm HIV. Lây truyền qua đường tình dục là quan trọng nhất mặc dù các đường lây truyền khác cũng quan trọng nhưng có số người nhiễm ít hơn**
- A. điều này là không đúng bởi vì bao cao su dễ bị rách và hay rò rỉ
- B. Điều này là không đúng vì những yếu tố khác như tiêm chích ma túy, truyền máu, không tiệt trùng cẩn thận bơm kim tiêm trong chăm sóc y tế là quan trọng hơn @
- C. Điều này là không đúng, bởi vì chỉ có hoạt động tình dục với gái mại dâm là không an toàn
- D. Điều này hoàn toàn không đúng
4. **Ở một số nước người ta đã áp dụng chương trình trao đổi bơm kim tiêm cho những người nghiện chích ma túy tĩnh mạch. Các chương trình này thất bại vì tiêm chích ma túy là mối quan tâm của ngành công an chứ không phải của ngành y tế công cộng**
- A. Điều này là đúng bởi vì chương trình đó làm tăng số người tiêm chích ma túy
- B. Điều này không đúng vì cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bắt tất cả những người tiêm chích ma túy lại và trừng phạt họ
- C. Điều này là không đúng bởi vì tỷ lệ nhiễm HIV ở những người tiêm chích ma túy ở những nước đã áp dụng chương trình trao đổi bơm kim tiêm cho những người nghiện chích ma túy tĩnh mạch thấp hơn so với những nước không áp dụng chương trình này @
- D. Điều này là không đúng vì HIV không lây truyền qua tiêm chích ma túy
5. **Phương thức lây truyền HIV chủ yếu hiện nay ở Việt Nam là**
- A. Tình dục đồng giới
- B. Tình dục khác giới
- C. Truyền máu và các sản phẩm của máu
- D. Tiêm chích ma túy @

129. **Tiêu chuẩn của 1 căn nguyên đối với bệnh ko nhiễm trùng**

- A. Không có yếu tố căn nguyên rõ ràng @
- B. Căn nguyên đa yếu tố
- C. Bệnh đa yếu tố
- D. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài

130. **Bảng sau trình bày kết quả của 1 nghiên cứu về yếu tố ... tương ứng với chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung**

Tầng lớp xã hội		Tỷ lệ % đáp ứng		
Cao		75		
Thấp		46		
Cả cao và thấp		53		
Tình trạng hôn nhân				
Có gia đình		82		
Sống độc thân		68		
Góa hay ly dị		43		
Tất cả các tình trạng hôn nhân		53		
Tầng lớp xã hội	Có gia đình	Sống độc thân	Góa/ly dị	chung
Cao	83	67	43	75
Thấp	81	89	43	46
chung	82	88	43	53

Từ các số liệu trên, suy luận nào sau đây là đúng:

- A. Phụ nữ có gia đình đáp ứng tốt
- B. Không thể rút ra kết luận gì từ những số liệu này và không ...hôn nhân của những người ở tầng lớp xã hội cao và thấp @
- C. Những phụ nữ có gia đình có tỷ lệ đáp ứng cao hơn những người sống độc thân hay góa bụa vì nhiều người trong số họ không thuộc tầng lớp...
- D. Không thể rút ra kết luận gì từ bảng số liệu này vì không ... nghiên cứu thuần tập hay nghiên cứu bệnh chứng

**131. Mối liên quan giữa béo phì và tăng huyết áp
(số liệu được trình bày trong bảng số liệu nguồn)**

	HA thấp	HA trung bình	HA cao	Tổng
Béo phì	50	50	100	200
Bình thường	170	30	100	400
Gầy	380	20	199	599
Tổng	600	100	399	1099

- A. $50/100 = 50\%$ số người có huyết áp trung bình là béo phì @
- B. $100/1000 = 10\%$ số người có huyết áp cao là béo phì
- C. $50/1000 = 5\%$ số người béo phì có huyết áp thấp
- D. $100/500 = 20\%$ số người có huyết áp cao là gầy

132. Chọn tình huống đúng

Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi. Những kết luận nào sau đây khẳng định sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi và đưa ra được bằng chứng về mối quan hệ nhân quả

- A. Nguy cơ K phổi tăng lên khi số thuốc lá hút hàng ngày tăng lên
- B. Nguy cơ K phổi tăng lên khi khoảng thời gian hút thuốc lá dài hơn
- C. Những người bỏ hút thuốc lá có tỷ lệ K phổi ở mức trung gian với những người ko hút thuốc lá và những người hiện đang hút thuốc lá
- D. Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cần thấy tỷ lệ có vết loét trên họng tăng lên sau khi hít thuốc lá vào phổi @

133. Một nghiên cứu bệnh chứng có đặc điểm sau trừ:

- a. Không quá tốn kém
- b. Có thể ước lượng được nguy cơ tương đối
- c. Có thể ước lượng được tỷ suất mới mắc @
- d. Có thể chọn nhóm chứng từ những bệnh khác

134. Hiện nay bệnh ho gà có khuynh hướng gia tăng ở cả nước phát triển vì

- A. Thuốc tiêm chủng ko còn hiệu quả
- B. Thuốc tiêm chủng ko có khả năng tạo miễn dịch vĩnh viễn
- C. Việc di dân từ những nước đang có dịch ho gà
- D. Việc tiêm chủng bị lơ là @

135. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh sởi là

- A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân
- C. Tiêm vacxin sởi cho trẻ từ 9 – 11 tháng tuổi @
- D. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân

136. Biện pháp xử trí nào kể sau ích lợi nhất cho 1 BN bị cúm

- A. Nghỉ ngơi trong giai đoạn sốt
- B. Dùng thuốc hạ nhiệt, giảm đau suốt thời gian bệnh
- C. Dùng vitamin C liều cao và tiêm tĩnh mạch
- D. Truyền dịch để cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan tích nước @

137. Rotavirus là nguyên nhân của 50% các trường hợp tiêu chảy ở trẻ em ở:

- A. 0 – 6 tháng tuổi
- B. 6 – 24 tháng tuổi @
- C. 24 – 36 tháng tuổi
- D. Từ 3 – 6 tuổi

138. Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là

- A. Người bệnh thể điển hình

- B. Người bệnh thể ko điển hình
- C. Người mang mầm bệnh
- D. Tất cả các loại kể trên @

139. Những người mang mầm bệnh thương hàn mãn tính phải

- A. Cách ly
- B. Cắt bỏ túi mật
- C. Đăng ký và theo dõi ở trung tâm y tế dự phòng nơi họ ở @
- D. Cách ly tại trung tâm y tế dự phòng và theo dõi 21 ngày

140. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh bại liệt là:

- A. Phát hiện sớm và điều trị BN
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của BN
- C. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân
- D. Uống vacxin sabin @

141. Nghiên cứu trường hợp

Một ng mẹ mang cháu gái 11 tháng bị ỉa chảy tới trạm y tế. người mẹ đang cho con bú. Bà nói rằng nhà bà ở xa trạm y tế nên ko thể trở lại trạm y tế trong vài này, ngay cả khi tình trạng cháu xấu đi. Người mẹ nói rằng bà cho cháu bé uống nước chè loãng khi cháu bị ỉa chảy, nhưng nghe nói ở trạm y tế có loại dịch tốt hơn nên bà đưa cháu tới trạm. Cán bộ y tế khám cháu bé nhưng không tìm thấy dấu hiệu mất nước. Cán bộ y tế hướng dẫn bà mẹ

- A. Khuyến người mẹ tiếp tục cho trẻ bú thường xuyên và tùy ý về số lượng và thời gian cho bú
- B. Khuyến người mẹ cho con ăn bột có thêm dầu thực vật, rau nấu kỹ và cho thêm 1 ít thịt nghiền. ngoài bú sữa mẹ, cần tiếp tục cho ăn ít nhất 6 lần một ngày @
- C. Giải thích cho người mẹ rằng nếu trẻ vẫn tiếp tục ỉa chảy sau khi dùng hết... thì cần cho trẻ uống nước cơm, nước cháo, đồng thời tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ
- D. Giải thích rằng nếu cháu tiếp tục ỉa chảy 3 – 4 ngày thì bà ta cần ngừng cho... đến khi cháu bé khỏi bệnh

142. Loại plasmodium nào dưới đây là nguyên nhân chính gây bệnh sốt rét..

- A. P. falciparum @
- B. P. vivax
- C. P.malariae
- D. P.ovale

143. Những chỉ số nào dưới đây dùng để phân loại mô hình dịch tễ sốt rét

- A. Chỉ số ký sinh trùng
- B. Chỉ số giao bào
- C. Chỉ số lách to
- D. Cả 3 chỉ số trên @

144. Mẫu số để đo lường tỷ suất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là:

- A. Số những trường hợp bệnh quan sát được
- B. Số những trường hợp ko có triệu chứng
- C. Số năm người quan sát được @
- D. Số người mất trong theo dõi

145. Nguồn truyền nhiễm chính của bệnh viêm não nhật bản là

- A. Dê, cừu
- B. Người bệnh
- C. Chim lợn @
- D. Người khỏi mang virus

146. Yếu tố quyết định đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ là

- A. Độc lực của vi sinh vật gây bệnh
- B. Cơ chế truyền nhiễm

- C. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh @
- D. Vị trí cảm nhiễm thứ hai của vi sinh vật gây bệnh

147. Kết hợp giả tạo có thể do

- A. May rủi
- B. 1 vài sự sai sót hệ thống
- C. Nhiều @
- D. Ghép cặp

148. Người mang mầm bệnh là nguồn lây truyền bệnh

- A. Bạch hầu @
- B. Bệnh sởi
- C. Ho gà
- D. Đậu mùa

149. Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm là

- A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm
- B. Các biện pháp đối với đường truyền nhiễm
- C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho nhân dân
- D. Tất cả các biện pháp kể trên @

150. Trong 1 nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc Artermisi. Để điều trị cho BN sốt rét qua theo dõi 1892h thấy có 244 TH mới mắc. Trong thời gian theo dõi 2 năm (1999-2001) . Tính tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu

- A. 0,13 @
- B. 0,17
- C. 0,15
- D. 0,19

34. Giai đoạn II trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm

- A. Nghiên cứu tính an toàn của thuốc
- B. Nghiên cứu tính hiệu quả của thuốc
- C. Thử nghiệm mang tính thử nghiệm lâm sàng @
- D. Thử nghiệm trên phạm vi nhỏ bệnh nhân cỡ mẫu 100 – 200

40. Người ta đã tiến hành thử nghiệm vaccin như sau : 1000 trẻ em 2 tuổi đã được chọn ngẫu nhiên để nhận một loại vaccin phòng bệnh nào đó và được theo dõi trong 10 năm, trong số những trẻ này, 80% trẻ đã không mắc bệnh . Trong những kết luận sau, kết luận nào là đúng nhất có liên quan tới hiệu quả của vaccin

- A. Vaccin là rất tốt vì tỷ lệ trẻ được gây miễn dịch cao
- B. Không thể kết luận được vì không nghiên cứu theo dõi những trẻ không được tiêm vaccin
- C. Vaccin không có hiệu quả lắm vì nó phải tạo ra tỷ lệ trẻ có miễn dịch cao hơn nữa
- D. Không thể kết luận được vì không làm kiểm dịch ý nghĩa thống kê

42. Lựa chọn tình huống sai

Tiêu chuẩn của một căn nguyên đối với bệnh nhiễm trùng theo dịch tễ Koch

- A. Chỉ thấy ở bệnh đó
- B. Không thấy ở bệnh khác
- C. Phân lập nuôi cấy và gây bệnh thực nghiệm được @
- D. Có thể thay đổi theo địa dư

43. Kết hợp nhân quả có thể được phiên giải qua các số đo sau trừ

- A. Nguy cơ tương đối (ước lượng điểm)
- B. Nguy cơ tương đối (ước lượng khoảng)
- C. Nguy cơ quy thuộc (ước lượng điểm và ước lượng khoảng)
- D. Tỷ suất chênh (ước lượng điểm và ước lượng khoảng) @

151. Biện pháp có hiệu quả trong phòng bệnh K gan nguyên phát là:
A. Tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ em @
B. Tập thể dục
C. Thức ăn có nhiều rau
D. Chẩn đoán phân biệt sớm
152. Biện pháp phát hiện sớm k cổ tử cung:
153. Các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành
154. Chỉ định tuân thủ chế độ nghiên cứu trong nghiên cứu can thiệp:
155. **Tăng cường tuân thủ trong nghiên cứu can thiệp bằng cách: Chạy thử**
156. Không chế sai số trong nghiên cứu can thiệp bằng cách: Làm mù
157. Mù kép là kỹ thuật
158. Nghiên cứu “ làm mù kép “ là 1 loại vaccin là 1 nghiên cứu trong đó:
A. Nhóm nghiên cứu nhận vaccin và nhóm chứng nhận placebo
B. Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu đều không biết bản chất của placebo @
C. Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu không ai biết ai sẽ nhận vaccin ai sẽ nhận placebo
159. Trong 1 nghiên cứu đo lường tần số các triệu chứng phụ do dùng 1 thuốc điều trị: Thiết kế nhiều thử nghiệm
160. Ưu điểm chủ yếu của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên:
161. Nguyên tắc phiên giải kết quả của trắc nghiệm thống kê: Không cứng nhắc giá trị P
162. Sai số quan sát gồm
163. Nhiều là yếu tố
164. Bệnh lây truyền theo đường phân – miệng
165. Bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào
A. Đặc tính vi sinh vật gây bệnh
B. Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh @
C. Vị trí cảm nhiễm thứ 2 của vi sinh vật gây bệnh
D. Biểu hiện lâm sàng
166. Nguồn truyền nhiễm của sởi
A. Người bệnh @
B. Người khỏi mang virus sởi
C. Người lành mang virus sởi
D. Người bệnh thể không điển hình
167. Đường lây truyền phổ biến nhất của dịch hạch
A. Đường hô hấp
B. Đường tiêu hóa
C. Đường máu @
D. Đường da và niêm mạc
168. Chẩn đoán phát hiện sớm 1 bệnh nhân trong 1 vụ dịch ko dựa vào
169. Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập
170. **Vaccin không được để ở nhiệt độ đóng băng là: Bạch hầu @**
171. Vaccin tiêm trong da: BCG @
172. Vaccin uống: Sabin @
173. **Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có hiện tượng tăng bằng biện pháp phòng chống quan trọng là**
A. **Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân**
B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để cho bệnh nhân
C. Tăng cường giáo dục sức khỏe và các biện pháp dự phòng cấp 1
D. Chẩn đoán và cách ly sớm @
174. Không phù hợp với Shigella
A. Thuộc gia đình Enterobacter
B. Có thể tiết ra nội độc tố lipopolisaccharide gây sốc @
C. Dòng Shigella typ huyết thanh 01 gây bệnh cảnh nặng nhất

- D. Gây tổn thương chủ yếu là các ổ loét hoại tử ở niêm mạc ruột non
175. Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa có hiện tượng tăng bang → phòng chống
- A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân
- B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để cho bệnh nhân @
- C. Tăng cường giáo dục sức khỏe và biện pháp dự phòng cấp 1
- D. Diệt côn trùng truyền bệnh
176. Tác nhân gây bệnh của nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu
177. Tác nhân gây bệnh của nhóm bệnh viêm não Nhật Bản: Chim, lợn
178. Dịch tễ sốt rét...
179. Truyền nhiễm chủ yếu dịch hạch ở Việt Nam
- A. Bọ chét
- B. Người bệnh thể hạch @
- C. Chuột
- D. Dơi
180. Trong sốt bại liệt, thể lâm sàng thường gặp nhất là Liệt mềm @
181. Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh: Đại @
182. Vacxin tiêm cho trẻ lúc 9 -12 tháng tuổi: Sởi @
183. Bệnh nào dưới đây tác nhân ko phải là virus: Ho gà
184. Các loài chim là ổ chứa thiên nhiên của bệnh: Viêm não Nhật Bản @
185. Mục đích của nghiên cứu mô tả nhằm?
186. Ưu nhược điểm của nghiên cứu tương quan
187. Khi mô tả 1 trường hợp / 1 chùm bệnh thì cỡ những ưu điểm nào
188. Điều tra ngang ko gắn liền với tỷ lệ nào (tỷ lệ mới mắc @
189. Định nghĩa, phân loại nghiên cứu bệnh chứng
- 190. 50. Biện pháp nào sai đây không phải là biện pháp khống chế nhiều**
- A. Chọn ngẫu nhiên
- B. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu
- C. Ghép cặp @
- D. Làm mù

58. Nguồn truyền nhiễm của bệnh than là

- A. Muối mang vi trùng than
- B. Đất có chứa nha bào than @
- C. Trâu, bò, dê
- D. Thực phẩm bị nhiễm vi trùng than

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DỊCH TỄ

1. KHỐI CẢM THỤ LÀ

- A. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CÓ MIỄN DỊCH VỚI BỆNH ĐÓ
- B. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẮC BỆNH
- C. NHỮNG NGƯỜI LÀNH MANG TRÙNG
- D. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG CÓ KHẢ NĂNG NHIỄM TRÙNG VÀ MẮC BỆNH
- ĐÁP ÁN: D**

2. NHỮNG YẾU TỐ SAU ĐÂY, YẾU TỐ NÀO KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ TRUNG GIẠN TRUYỀN BỆNH ĐỐI VỚI CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP

- A. NƯỚC
- B. ĐỜM
- C. KHÔNG KHÍ
- D. THỰC PHẨM
- ĐÁP ÁN: D**

3. TRONG THỬ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆU QUẢ CỦA AZT TRÊN BỆNH NHÂN AIDS, MỘT NHÓM BỆNH NHÂN DÙNG AZT, MỘT NHÓM BỆNH NHÂN DÙNG PLACEBO, NGHIÊN CỨU NÀY MŨ ĐÔI NẾU

A. 3 NHÓM: 2 NHÓM BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ KHÔNG BIẾT BỆNH NHÂN DÙNG LOẠI THUỐC GÌ

B. CẢ 2 NHÓM BỆNH NHÂN ĐỀU MŨ

C. CẢ 2 NHÓM BỆNH NHÂN KHÔNG BIẾT MÌNH DÙNG THUỐC GÌ

D. CẢ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KHÔNG BIẾT BỆNH NHÂN DÙNG THUỐC GÌ

ĐÁP ÁN: A

4. NHẬN XÉT NÀO SAU ĐÂY MÔ TẢ ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN

A. NÓ LOẠI TRỪ ĐƯỢC SỰ TỰ LỰA CHỌN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀO CÁC NHÓM ĐIỀU TRỊ KHÁC NHAU

B. NÓ THU NHẬN NHỮNG BỆNH NHÂN ĐẠI DIỆN

C. NÓ TRÁNH ĐƯỢC SAI LỆCH QUAN SÁT

D. NÓ MANG LẠI KẾT QUẢ CÓ THỂ ÁP DỤNG Ở NHỮNG BỆNH NHÂN KHÁC

ĐÁP ÁN: A

5. MỘT BỆNH ĐƯỢC GÂY RA BAO GIỜ CŨNG DO

A. TÁC NHÂN GÂY BỆNH GÂY NÊN

B. SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ THỂ YẾU

C. CHỦ YẾU DO CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (YẾU TỐ NGUY CƠ) TÁC ĐỘNG VÀO

D. 1 MẠNG LƯỚI CÁC NGUYÊN NHÂN

ĐÁP ÁN: D

6. ĐỀ NGỘ ĐỘC AFLATOXIN CÓ THỂ GÂY UNG THƯ GAN NGƯỜI TA LẤY SỐ LIỆU TRONG CÙNG 1 NĂM CỦA 16 QUỐC GIA VỀ TỶ XUẤT MỚI MẮC UNG THƯ GAN VÀ NỒNG ĐỘ TRUNG BÌNH CỦA AFLATOXIN TRONG THỨC ĂN VÀ XEM CHÚNG CÓ TƯƠNG QUAN VỚI NHAU HAY KHÔNG, NGHIÊN CỨU NÀY GỌI LÀ

A. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG

B. NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ

C. NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN

D. NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG

ĐÁP ÁN: C

7. NHỮNG YẾU TỐ SAU YẾU TỐ NÀO KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ TRUNG GIAN TRUYỀN NHIỄM

A. ĐỘNG VẬT CHÂN ĐÓT

B. NƯỚC

C. THỰC PHẨM

D. GIÓ

ĐÁP ÁN: D

8. TRƯỜNG HỢP NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM BỆNH DỊCH HẠCH

A. CHUỘT SỐNG

B. CHUỘT CHẾT TỰ NHIÊN

C. BỌ CHẾT

D. 1 BỆNH NHÂN BỊ BỆNH DỊCH HẠCH CÓ HẠCH Ở BÊN VỪA VÀO VIỆN

ĐÁP ÁN: B

9. TỶ XUẤT CHẾT TRẺ EM LÀ

A. SỐ CHẾT CỦA TRẺ EM < 1 TUỔI CHIA CHO SỐ SINH SỐNG TRONG CÙNG MỘT THỜI KỲ TRONG MỘT DÂN SỐ NHẤT ĐỊNH

B. SỐ CHẾT CỦA TRẺ EM < 15 TUỔI DO MẮC 1 BỆNH NÀO ĐÓ CHIA CHO SỐ TRẺ EM BỊ MẮC BỆNH TRONG DÂN SỐ NHẤT ĐỊNH

C. SỐ CHẾT CỦA TRẺ EM < 15 TUỔI CHIA CHO SỐ SINH SỐNG TRONG CÙNG MỘT THỜI KỲ TRONG MỘT DÂN SỐ NHẤT ĐỊNH

D. SỐ CHẾT CỦA TRẺ EM < 1 TUỔI CHIA CHO SỐ TRẺ EM MẮC BỆNH TRONG CÙNG MỘT THỜI KỲ TRONG MỘT DÂN SỐ NHẤT ĐỊNH

ĐÁP ÁN: A

10. DỊCH TỄ HỌC LÀ

A. 1 MÔN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÂN BỐ CỦA 1 BỆNH TRUYỀN NHIỄM, YẾU TỐ QUY ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ ĐÓ

B. 1 MÔN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU TÀN XUẤT MẮC HOẶC CHẾT ĐỐI VỚI BỆNH TRẠNG CÙNG VỚI NHỮNG...

C. 1 MÔN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÂN BỐ CỦA 1 BỆNH TRUYỀN NHIỄM HAY KHÔNG TRUYỀN NHIỄM

D. 1 MÔN NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH DỊCH

ĐÁP ÁN: B

11. CÓ MỘT VỤ DỊCH TIÊU CHẢY NHỎ XẢY RA TẠI MỘT TRƯỜNG MẪU GIÁO, CÁC CÁN BỘ Y TẾ ĐÃ XÉT NGHIỆM CHO CÁC CHÁU THẤY TÁC NHÂN GÂY BỆNH LÀ SAMONELLA, TRONG NHỮNG GIẢ THUYẾT SAU ĐÂY GIẢ THUYẾT NÀO ĐƯỢC LOẠI BỎ ĐẦU TIÊN

A. NGUỒN NƯỚC UỐNG BỊ NHIỄM BỆNH

B. MỘT TRONG CÁC MÓN ĂN BỊ NHIỄM BỆNH

C. MỘT TRONG SỐ CÁC CHÁU BỊ NHIỄM SAMONELLA

D. MỘT TRONG CÁC CÔ PHỤC VỤ BỊ NHIỄM BỆNH

ĐÁP ÁN: C

12. NGUY CƠ MẮC BỆNH MẠCH VÀNH TIM TRONG 1 NĂM TRONG NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ Ở DÂN SỐ A LÀ 669/100000, NGUY CƠ Ở NHÓM NGƯỜI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ LÀ 413/100000, NGUY CƠ TƯƠNG ĐỐI Ở NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ LÀ

A. 1.62

B. 256/100000

C. 0.62

D. PHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ TRONG CỘNG ĐỒNG

ĐÁP ÁN: A

13. TRONG CUỘC NGHIÊN CỨU NGANG VỀ LOÉT DẠ DÀY TRONG 1 CỘNG ĐỒNG, TỈ LỆ NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỦ TRIỆU CHỨNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN LOÉT DẠ DÀY LÀ 80/100000 ĐÀN ÔNG Ở LỨA TUỔI 35 – 49 VÀ 90/100000 PHỤ NỮ Ở LỨA TUỔI 35 – 49, NGƯỜI TA CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG Ở NHÓM TUỔI NÀY PHỤ NỮ CÓ NGUY CƠ CAO BỊ LOÉT DẠ DÀY. KẾT LUẬN NÀY LÀ

A. KHÔNG ĐÚNG VÌ KHÔNG THỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC TỈ LỆ MỚI MẮC HAY TỈ LỆ HIỆN MẮC

B. ĐÚNG

C. KHÔNG ĐÚNG VÌ KHÔNG NHẬN BIẾT ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA THUẦN TẬP

D. KHÔNG ĐÚNG VÌ KHÔNG CÓ NHÓM SO SÁNH HAY ĐỐI CHỨNG

ĐÁP ÁN: D

14. ĐỐI VỚI CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP MUỐN PHÒNG DỊCH TỐT QUAN TRỌNG NHẤT LÀ

A. CÁCH LY NGƯỜI BỆNH

B. UỐNG THUỐC DỰ PHÒNG

C. GÂY MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU VÀ KHÔNG ĐẶC HIỆU

D. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

ĐÁP ÁN: C

15. CÓ 1 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ TỈ LỆ K CỐ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG TEST PAPANICOLAOU VÀ TÌM NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TÌNH TRẠNG NÀY (TÁC GIẢ ĐỀ TÀI ĐÃ LÀM GÌ)

A. CÔNG TÁC DỰ PHÒNG CẤP 2

- B. CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG ĐỂ THỰC HIỆN 3 MỨC DỰ PHÒNG
 - C. CÔNG TÁC DỰ PHÒNG CẤP 1
 - D. CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA
- ĐÁP ÁN: A

16. ĐỐI VỚI TRUYỀN NHIỄM LÂY QUA ĐƯỜNG MÁU MUỐN PHÒNG DỊCH TỐT QUAN TRỌNG NHẤT LÀ
- A. DIỆT VECTƠ TRUYỀN BỆNH VÀ AN TOÀN TRUYỀN MÁU VÀ TIÊM CHÍCH
 - B. GIÁO DỤC CHO NGƯỜI LÀNH BIẾT CÁCH PHÒNG TRÁNH
 - C. CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ TRIỆT ĐỂ NGUỒN TRUYỀN NHIỄM
 - D. DỰ PHÒNG BẰNG VACCINE VÀ NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG CHO NGƯỜI BỆNH
- ĐÁP ÁN: A

17. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG CÓ THỂ DÙNG ĐỂ TÍNH SỐ ĐO HIỆN MẮC
- A. CÚM
 - B. VIÊM MÀNG NÃO
 - C. CAO HUYẾT ÁP
 - D. DẠI
- ĐÁP ÁN: C

18. TRONG THỬ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆU QUẢ CỦA AZT TRÊN BỆNH NHÂN AIDS, 1 NHÓM BỆNH NHÂN ĐƯỢC DÙNG PLACEBO, NHÓM NÀY GỌI LÀ
- A. NHÓM BỆNH
 - B. NHÓM BỆNH NHE
 - C. NHÓM TIẾP XÚC
 - D. NHÓM ĐỐI CHỨNG
- ĐÁP ÁN: D

19. TRONG NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÚT THUỐC LÁ VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM, YẾU TỐ GÂY NHIỀU LÀ
- A. CAO HUYẾT ÁP
 - B. HÚT THUỐC LÁ
 - C. BỆNH NHÂN BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM
 - D. TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
- ĐÁP ÁN: A

20. NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ CÓ ƯU ĐIỂM
- A. ÍT TỐN KÉM SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH KHÁC
 - B. MỖI QUAN HỆ THỜI GIAN GIỮA NGUYÊN NHÂN – KẾT QUẢ RÕ RÀNG
 - C. CHO PHÉP ĐÁNH GIÁ MỘT KẾT QUẢ DO NHIỀU TIẾP XÚC
 - D. HIỆU QUẢ KHI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC BỆNH HIỂM
- ĐÁP ÁN: B

21. ĐIỀU TRỊ ĐÁI ĐƯỜNG LÀ DỰ PHÒNG
- A. CẤP 0
 - B. CẤP 1
 - C. CẤP 3
 - D. CẤP 2
- ĐÁP ÁN: D

22. NGUY CƠ MẮC BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM Ở NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ LÀ 0.1 VÀ NGUY CƠ Ở NGƯỜI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ LÀ 0.02, NẾU NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ BỎ HÚT THÌ NGUY CƠ CỦA HỌ SẼ

GIẢM BỐT

- A. 0.2
- B. 0.08
- C. 0.12
- D. 5.0

ĐÁP ÁN: B

23. TRONG NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẦN PHẢI MÔ TẢ NHỮNG YẾU TỐ VỀ CON NGƯỜI VÌ

- A. ĐỂ TÌM NHÓM NGUY CƠ CAO TRONG CỘNG ĐỒNG
- B. NHỮNG YẾU TỐ VỀ CON NGƯỜI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN TỈ LỆ MẮC BỆNH
- C. TỈ LỆ MẮC BỆNH ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN 1 HAY NHIỀU ĐẶC ĐIỂM CỦA CON NGƯỜI
- D. ĐỂ TÌM YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH

ĐÁP ÁN: C

24. PHẦN TRĂM NGUY CƠ QUY TRÁCH DÂN SỐ LÀ

- A. TỈ LỆ BỆNH TRONG DÂN SỐ NẾU TOÀN BỘ DÂN SỐ KHÔNG CÒN TIẾP XÚC VỚI YẾU TỐ NGUY CƠ
- B. TỈ LỆ DÂN SỐ CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH
- C. TỈ LỆ GIẢM BỐT BỆNH TRONG DÂN SỐ NẾU TOÀN BỘ DÂN SỐ KHÔNG CÒN TIẾP XÚC VỚI YẾU TỐ NGUY CƠ.
- D. NGUY CƠ CỦA DÂN SỐ NẾU TOÀN BỘ DÂN SỐ KHÔNG CÒN TIẾP XÚC VỚI YẾU TỐ NGUY CƠ

ĐÁP ÁN: C

25. TRONG NĂM 1997 MỘT DÂN SỐ CÓ 100000 TRẺ, CÓ 120 TRẺ BỊ VIÊM MÀNG NÃO VÀ 24 TRẺ BỊ CHẾT DO BỆNH NÀY, TỈ LỆ CHẾT/MẮC CỦA VIÊM MÀNG NÃO LÀ

- A. 24/120
- B. 120/100000
- C. 24/100000
- D. TẤT CẢ SAI

ĐÁP ÁN: A

26. NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ

- A. ÍT TỐN KÉM SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH KHÁC
- B. MỖI QUAN HỆ THỜI GIAN RÕ RÀNG
- C. HIỆU QUẢ KHI NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC BỆNH HIỂM
- D. CHO PHÉP ĐÁNH GIÁ 1 KẾT CUỘC DO NHIỀU TIẾP XÚC

ĐÁP ÁN: C

27. CUNG CẤP NƯỚC SẠCH LÀM GIẢM TỈ LỆ MẮC TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM < 5 TUỔI, ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY NGHIÊN CỨU NÀO SAU ĐÂY THÍCH HỢP

- A. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG
- B. NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG
- C. NGHIÊN CỨU CAN THIỆP
- D. NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ

ĐÁP ÁN: C

28. FLAGENTYL CÓ TỐT HƠN FLAGYL TRONG ĐIỀU TRỊ LÝ AMIP Ở TRẺ EM, TA DÙNG NGHIÊN CỨU NÀO SAU ĐÂY

- A. NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ
- B. NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN
- C. NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG
- D. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG

ĐÁP ÁN: C

29. MỘT NGHIỆM PHÁP SÀNG TUYỂN PHÁT HIỆN UNG THƯ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN 400 PHỤ NỮ K VÚ (ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG GIẢI PHẪU BỆNH) VÀ 400 PHỤ NỮ KHÔNG BỊ K VÚ. KẾT QUẢ DƯỠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP NÀY ĐƯỢC THẤY Ở 100 BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ VÀ 50 PHỤ NỮ

BÌNH THƯỜNG. ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA NGHIỆM PHÁP LÀ

- A. 20%
- B. 67%
- C. 87%
- D. 25%

ĐÁP ÁN: C

30. MỘT NGHIỆM PHÁP SÀNG TUYỂN PHÁT HIỆN UNG THƯ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN 400 PHỤ NỮ K VÚ (ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG GIẢI PHẪU BỆNH) VÀ 400 PHỤ NỮ KHÔNG BỊ K VÚ. KẾT QUẢ DƯỠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP NÀY ĐƯỢC THẤY Ở 100 BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ VÀ 50 PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG. GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN DƯỠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP LÀ

- A. 67%
- B. 33%
- C. 87%
- D. 12%

ĐÁP ÁN: A

31. NGHIÊN CỨU "LÀM MÙ ĐÔI" MỘT LOẠI VACCINE LÀ MỘT NGHIÊN CỨU TRONG ĐÓ

- A. CẢ NGƯỜI NGHIÊN CỨU LẪN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU KHÔNG AI BIẾT AI SẼ NHẬN VACCINE AI SẼ NHẬN PLACEBO
- B. NHÓM NGHIÊN CỨU NHẬN VACCINE CÒN NHÓM CHỨNG NHẬN PLACEBO
- C. CẢ NGƯỜI NGHIÊN CỨU LẪN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU KHÔNG BIẾT BẢN CHẤT CỦA PLACEBO
- D. CẢ NHÓM NGHIÊN CỨU LẪN NHÓM CHỨNG KHÔNG NHÓM NÀO BIẾT AI LÀ NHÀ NGHIÊN CỨU

ĐÁP ÁN: A

32. NGƯỜI CÓ SỨC KHỎE LÀ NGƯỜI

- A. KHÔNG CÓ BỆNH GÌ NẶNG TRONG NĂM
- B. LÀM RA NHIỀU SẢN PHẨM CHO XÃ HỘI
- C. THOẢI MÁI HOÀN TOÀN CẢ THỂ CHẤT, TÌNH THẦN VÀ XÃ HỘI
- D. HOÀN TOÀN KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỖ CỦA BÁC SĨ

ĐÁP ÁN: C

33. HÌNH ẢNH "TẢNG BĂNG TRÔI" TRONG CỘNG ĐỒNG NÓI LÊN ĐIỀU GÌ

- A. CHỈ 1 SỐ ÍT CÁ THỂ CỦA BỆNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG
- B. LÀ BỆNH PHỔ BIẾN TRONG CỘNG ĐỒNG
- C. LÀ HÌNH ẢNH NỔI TRÔI CẦN QUAN TÂM TRONG CỘNG ĐỒNG
- D. LÀ BỆNH DỄ PHÁT HIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG

ĐÁP ÁN: A

34. CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG LÀ

- A. TÌM NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY BỆNH TRONG CỘNG ĐỒNG HOẶC ĐANG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY BỆNH
- B. TÌM TỈ LỆ HIỆN MẮC CỦA BỆNH TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỂ CÓ KẾ HOẠCH CAN THIỆP
- C. PHÁT HIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG NHỮNG BỆNH TRẠNG CÒN Ở TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN LÂM SÀNG
- D. KHÁM ĐỀ TÌM NHỮNG BỆNH NHÂN TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ

ĐÁP ÁN: C

35. ĐỂ CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TA DÙNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NÀO

- A. CHỈ CẦN NHỮNG HỘI CHỨNG BỆNH QUA THĂM KHÁM LÂM SÀNG
- B. CÁC CUỘC ĐIỀU TRA VÀ KỸ THUẬT SÀNG TUYỂN
- C. NHỮNG KỸ THUẬT KHÁM LÂM SÀNG VÀ NHỮNG XÉT NGHIỆM CLS
- D. CHỈ DÙNG 1 TRONG NHỮNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CLS CÓ GIÁ TRỊ NHẤT TRONG CHẨN ĐOÁN

ĐÁP ÁN: B

36. NHIỆM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ

- A. NHỮNG BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐANG NẪM ĐIỀU TRỊ TRONG BỆNH VIỆN
B. NHỮNG BỆNH NHIỄM TRÙNG MÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀO CƠ THỂ BỆNH NHÂN TRONG LÚC HỌ ĐANG NẪM VIỆN
C. NHỮNG BỆNH NHIỄM TRÙNG MÀ BỆNH NHÂN KHỞI PHÁT TRONG THỜI GIAN NẪM VIỆN
D. NHỮNG BỆNH NHIỄM TRÙNG NẶNG CẦN PHẢI ĐƯA VÀO ĐIỀU TRỊ TRONG BỆNH VIỆN
ĐÁP ÁN: B

37. TRƯỜNG HỢP NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN
A. 1 BỆNH NHÂN VÀO VIỆN ĐỂ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT ĐƯỢC 1.5 NGÀY THÌ MẮC CHỨNG TIÊU CHẢY, XÉT NGHIỆM PHÂN CÓ SHIGELLA
B. 1 BÉ GÁI 5 TUỔI VÀO KHOA NHIỄM ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI ĐƯỢC 5 NGÀY THÌ BỊ THÊM BỆNH CÚM
C. 1 BỆNH NHÂN VÀO NẪM VIỆN ĐÃ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG VỚI LÝ DO GỠ XƯƠNG ĐÙI THÌ LÊN CÒN SỐT, XÉT NGHIỆM THẤY KST SỐT RÉT TRONG MÁU
D. 1 BỆNH NHÂN MÔ SỎI MẬT ĐƯỢC 5 NGÀY THÌ THẤY NHIỄM TRÙNG Ở CHỖ DẪN LƯU
ĐÁP ÁN: C

38. TRONG NHÓM VI KHUẨN GRAM (-) LOẠI VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG PHỔ BIẾN NHẤT LÀ
A. LAO
B. TỤ CẦU
C. LIÊN CẦU
D. TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU
ĐÁP ÁN: D

39. TRONG NHÓM VI KHUẨN GRAM (-) LOẠI VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG PHỔ BIẾN NHẤT LÀ
A. NHÓM KES (RLEBSIELLA, ENTEROBACTER, SERRATIA)
B. SAMONELLA
C. E.COLI
D. SHIGELLA
ĐÁP ÁN: C

40. CON VI KHUẨN GÂY "NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI" ĐIỂN HÌNH LÀ
A. TỤ CẦU VÀNG
B. LIÊM CẦU NHÓM A
C. TK LAO
D. TK MỦ XANH
ĐÁP ÁN: D

41. HIỆN NAY VI KHUẨN ÍT KHÁNG THUỐC NHẤT LÀ
A. TK MỦ XANH
B. TK LAO
C. TỤ CẦU VÀNG
D. LIÊM CẦU NHÓM A
ĐÁP ÁN: D

42. TỤ CẦU THƯỜNG GÂY BỘI NHIỄM NHIỀU NHẤT Ở KHOA
A. NHI VÀ NGOẠI
B. SẢN VÀ NGOẠI
C. NỘI VÀ NHI
D. NHIỄM VÀ NỘI
ĐÁP ÁN: A

43. NHẬN XÉT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ĐÚNG, NIÊM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ

- A. DO DỤNG CỤ Y TẾ CHƯA VÔ TRÙNG
- B. Ô NIÊM MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
- C. NHÂN VIÊN Y TẾ VẬN CHUYỂN MẦM BỆNH KHI ĐI LẠI KHI THĂM KHÁM
- D. DO SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN

ĐÁP ÁN: D

44. Ở VIỆT NAM BỆNH NÀO CÓ TỶ SUẤT TỬ VONG CAO NHẤT

- A. THƯƠNG HÀN
- B. AIDS
- C. DẠI
- D. LAO

ĐÁP ÁN: D

45. TRONG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA TRỰC TIẾP TỶ SUẤT TỬ VONG

- A. KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐỂ SO SÁNH NHIỀU NHÓM DÂN SỐ
- B. NGƯỜI TA ÁP ĐẶT CẤU TRÚC DÂN SỐ CỦA DÂN SỐ CHUẨN LÊN 2 NHÓM DÂN SỐ
- C. NÊN ÁP DỤNG KHI 2 NHÓM DÂN SỐ CÓ QUY MÔ NHỎ
- D. NGƯỜI TA ÁP ĐẶT TỶ SUẤT TỬ VONG CỦA DÂN SỐ CHUẨN LÊN 2 NHÓM DÂN SỐ

ĐÁP ÁN: B

46. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA TRỰC TIẾP CÓ ƯU ĐIỂM HƠN PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA GIÁN TIẾP "NGOẠI TRỪ"

- A. CÓ THỂ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TỶ SUẤT TỬ VONG CỦA TỪNG NHÓM TUỔI Ở DÂN SỐ MUỐN ĐƯỢC CHUẨN HÓA
- B. CÓ THỂ SO SÁNH NHIỀU DÂN SỐ MỘT CÁCH TRỰC TIẾP
- C. CÓ TÍNH TIN CẬY CAO
- D. CÓ THỂ TÍNH TỶ SUẤT TỬ VONG CỦA NHIỀU DÂN SỐ TRÊN CÙNG MỘT CẤU TRÚC DÂN SỐ CHUẨN

ĐÁP ÁN: A

47. TRONG NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG NHẪM CHỨNG MINH ĂN NHIỀU CHẤT BÉO VÀ K VÚ TRÊN PHỤ NỮ TP.HCM (NHÓM CHỨNG LÀ MẪU ĐẠI DIỆN CHO PHỤ NỮ THÀNH PHỐ), NÊN TÌM NHỮNG TRƯỜNG HỢP K VÚ Ở

- A. TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ K VÚ Ở TP.HCM NHƯNG LOẠI BỎ NHỮNG PHỤ NỮ TỪ CÁC TỈNH KHÁC TỚI
- B. BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.HCM
- C. TẤT CẢ CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ K VÚ TẠI TP.HCM
- D. BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (TUYÊN TUYÊN TRÁCH PHÍA NAM)

ĐÁP ÁN: A

48. MỘT KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM VỚI GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH LÀ 18g/100ml, ĐỘ LỆCH CHUẨN LÀ 1.5/100ml, CÓ NGHĨA LÀ

- A. GIÁ TRỊ THẬT TỪ 15-21g/100ml
- B. GIÁ TRỊ THẬT TỪ 16.5-19.5g/100ml
- C. NẾU TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM LẠI TRÊN CÙNG 1 MẪU, 95% CÁC GIÁ TRỊ SẼ NẪM TRONG KHOẢNG
- D. SAI SỐ QUÁ LỚN KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC BẤT KÌ GIÁ TRỊ NÀO

ĐÁP ÁN: C

49. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG CÓ THỂ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU "NGOẠI TRỪ"

- A. TÌM TỈ LỆ NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ
 - B. TÌM TỈ LỆ BƯỚU CỎ TRONG DÂN SỐ
 - C. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN BỆNH BẠI LIỆT
 - D. TÌM TỶ SUẤT CHẾT/MẮC CỦA BỆNH THƯỜNG HÀN
- ĐÁP ÁN: D

50. TRONG 1 NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ TÍNH ĐƯỢC $RR = 2.3$ ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ
- A. 1 NGƯỜI TIẾP XÚC CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH NHIỀU HƠN NGƯỜI KHÔNG TIẾP XÚC 2.3 LẦN
 - B. CỨ 10 NGƯỜI TIẾP XÚC THÌ 2.3 NGƯỜI MẮC BỆNH
 - C. CỨ 2.3 NGƯỜI TIẾP XÚC MẮC BỆNH THÌ CÓ 1 NGƯỜI TIẾP XÚC KHÔNG MẮC BỆNH
 - D. SỐ NGƯỜI TIẾP XÚC MẮC BỆNH NHIỀU HƠN SỐ NGƯỜI KHÔNG TIẾP XÚC 2.3 LẦN
- ĐÁP ÁN: A:37000000: